

COLEÇÃO PROFISSIONAL • VOL. 04

Prescrição de Exercícios

Do FITT-VP à sessão pronta: como traduzir objetivo em programa — intensidade, volume, seleção, ordem e progressão — com base na melhor evidência.

MANUAL TÉCNICO

FONTES A1 / A2 • QUALIS

PARA PROFISSIONAIS DE ED. FÍSICA

Gustavo Correia Vieira

PREPARAÇÃO FÍSICA & PERFORMANCE • CREF

1ª Edição • 2026

Coleção Profissional

PER4MANCE

Sumário

APRESENTAÇÃO

–	Do diagnóstico ao programa	03
---	----------------------------	----

PARTE I • O MODELO FITT-VP

1.0	Os princípios da prescrição	04
1.1	O modelo FITT-VP	05
1.2	Intensidade: prescrever e medir	06
1.3	Volume: a dose que constrói	07
1.4	Tipo e especificidade	08

PARTE II • PRESCRIÇÃO RESISTIDA

2.0	Variáveis por objetivo	10
2.1	Seleção de exercícios	11
2.2	Ordem dos exercícios	12
2.3	Intervalo e tempo sob tensão	13

PARTE III • MONTANDO A SESSÃO E A SEMANA

3.0	A anatomia de uma sessão	15
3.1	Divisões de treino e frequência	16
3.2	Prescrição aeróbia	17
3.3	Flexibilidade e neuromotor	18
3.4	Treino concorrente e emagrecimento	19

PARTE IV • PROGRESSÃO & INDIVIDUALIZAÇÃO

4.0	Como progredir	21
4.1	Autorregulação	22
4.2	Populações e segurança	23

PARTE V • FERRAMENTAS

5.0	Estudo de caso · modelo · checklist · glossário	25
-----	---	----

Do Diagnóstico ao Programa

Avaliar mostra onde o aluno está. Prescrever é decidir, com método, como levá-lo adiante. É aqui que o profissional prova o seu valor.

Se a avaliação é o diagnóstico, a prescrição é o tratamento. É o momento em que todo o conhecimento — fisiologia, biomecânica, avaliação — converge numa decisão concreta: **quais exercícios, com qual carga, quantas vezes, em que ordem e como progredir**. Prescrever bem é o que transforma intenção em resultado.

O problema é que muita prescrição na prática é feita por hábito ou imitação: copia-se um treino da internet, repete-se o que "sempre funcionou", ou empilham-se exercícios sem uma lógica clara. O resultado é programa sem direção — que às vezes funciona por acaso, mas não por método. O profissional que domina a prescrição faz o oposto: cada variável é uma **escolha justificável**.

Este manual organiza a prescrição em torno de um arcabouço consagrado — o **FITT-VP** do ACSM — e o aplica à musculação, ao treino aeróbico e à montagem da sessão e da semana. As recomendações de carga, volume e progressão são ancoradas em literatura **A1/A2** (ACSM/Garber 2011; Schoenfeld), com tabelas prontas para a prática.

COMO USAR ESTE MATERIAL

A Parte I apresenta o FITT-VP e suas variáveis-chave. A Parte II detalha a prescrição resistida (objetivo, seleção, ordem, descanso). A Parte III monta a sessão, a semana e o aeróbico. A Parte IV cuida da progressão e da individualização. A Parte V traz estudo de caso, modelo preenchível, checklist e glossário.

A DEFINIÇÃO QUE GUIA TUDO

Prescrição de exercício é a manipulação sistemática das variáveis de treino (frequência, intensidade, tempo, tipo, volume e progressão) para conduzir um aluno específico, do seu ponto atual ao seu objetivo, com segurança e eficiência.

1.0

Os Princípios da Prescrição

Antes das variáveis, as leis que as governam. Toda prescrição que funciona respeita estes princípios — e toda que falha violou algum.

A prescrição não é um conjunto de regras arbitrárias: ela aplica princípios biológicos do treinamento. Conhecê-los é entender o "porquê" por trás de cada variável que vamos manipular:

PRINCÍPIO	IMPLICAÇÃO PARA A PRESCRIÇÃO
Sobrecarga	O estímulo precisa superar a demanda habitual para gerar adaptação. Carga insuficiente não treina.
Progressão	A sobrecarga deve crescer ao longo do tempo, senão a adaptação estaciona (acomodação).
Especificidade	A adaptação é específica ao estímulo: o treino deve se parecer com o objetivo.
Individualização	Mesma prescrição rende diferente em pessoas diferentes; calibrar é obrigatório.
Reversibilidade	Adaptações regredem com a interrupção; manutenção também é prescrição.
Variação	Variar o estímulo (dentro da especificidade) sustenta o progresso e a adesão.

Repare que esses princípios são a ponte entre a teoria e a prática: cada variável do FITT-VP (que veremos a seguir) existe justamente para **operacionalizar** um ou mais deles. Prescrever é, no fundo, aplicar esses princípios de forma quantificada e organizada para um aluno real.

O PRINCÍPIO MAIS NEGLIGENCIADO

A **progressão**. Muitos programas têm boa sobrecarga inicial, mas nunca avançam — o aluno faz os mesmos pesos por meses. Sem progressão sistemática, o melhor treino do mundo vira manutenção. Voltaremos a isso em detalhe na Parte IV.

1.1

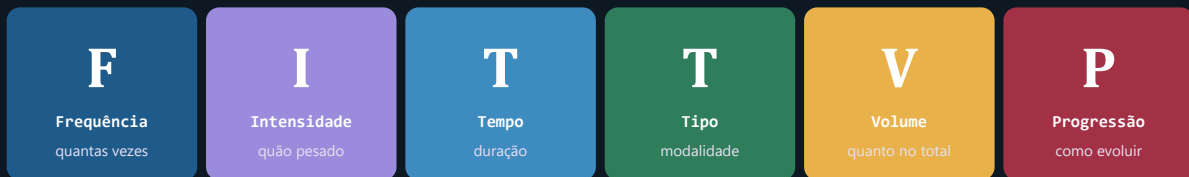
O Modelo FITT-VP

Um acrônimo que organiza toda a prescrição. Domine-o e você nunca mais esquece uma variável ao montar um treino.

O FITT-VP é o arcabouço de prescrição consagrado pelo ACSM (Garber et al., 2011). Ele lista as variáveis que, juntas, definem qualquer programa — de musculação a corrida. É a checklist mental do profissional:

FIG. 1.1 – O MODELO FITT-VP

o esqueleto de toda prescrição de exercício (ACSM · Garber et al., 2011)



Frequência, Intensidade, Tempo, Tipo, Volume e Progressão: as seis variáveis que, combinadas, compõem qualquer prescrição de exercício.

- **Frequência:** quantas vezes por semana (sessões, ou frequência por grupo muscular/qualidade).
- **Intensidade:** quão pesado/forte (a variável mais determinante — detalhada a seguir).
- **Tempo:** duração da sessão ou do estímulo.
- **Tipo:** a modalidade/exercício escolhido (resistido, aeróbio, etc.).
- **Volume:** a quantidade total de trabalho (séries × reps; ou tempo × frequência).
- **Progressão:** como as variáveis avançam ao longo do tempo.

A força do modelo é garantir que **nenhuma variável seja esquecida**. Um treino "incompleto" quase sempre falhou em definir uma delas — frequência baixa demais, intensidade não controlada, ou ausência de progressão. Percorrer o FITT-VP ao montar (e ao revisar) um programa é um hábito que evita a maioria dos erros de prescrição.

POR QUE O "VP" FOI ACRESCENTADO

O modelo clássico era apenas "FITT". O ACSM acrescentou o **V** (volume) e o **P** (progressão) justamente porque eram as peças mais esquecidas — e as que mais decidem se o programa evolui ou estagna. Definir frequência, intensidade, tempo e tipo monta o treino; dosar o volume e planejar a progressão é o que o faz **entregar resultado ao longo do tempo**.

EVIDÊNCIA

Garber CE et al. (ACSM Position Stand). "Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults." *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(7):1334–59, 2011 [A1].

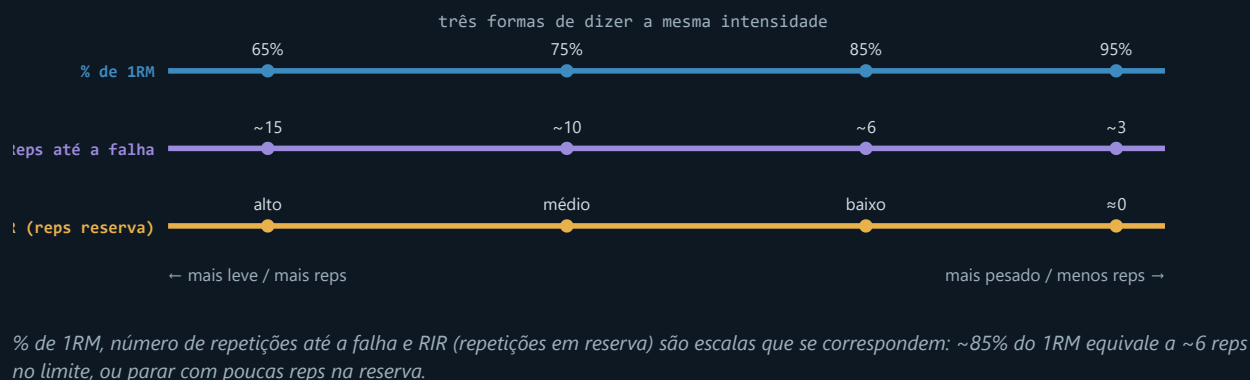
1.2

Intensidade: Prescrever e Medir

A variável mais poderosa — e a mais confundida. Há várias formas de expressar intensidade, e o profissional precisa transitar entre elas.

A intensidade é, provavelmente, a variável mais determinante do resultado. No treino resistido, ela costuma ser expressa de três formas **intercambiáveis**, e dominar a tradução entre elas é essencial:

FIG. 1.2 – TRÊS FORMAS DE DIZER A MESMA INTENSIDADE



- **% de 1RM:** a carga como fração do máximo. Precisa, mas exige testar (ou estimar) o 1RM e varia com a fadiga do dia.
- **Faixa de repetições:** prática e autorregulável; "8–12 reps" implica uma faixa de intensidade. A mais usada no dia a dia.
- **RIR / RPE:** repetições em reserva (ou esforço percebido) — quão perto da falha. Ajusta a intensidade ao estado real do aluno.

No treino aeróbico, a intensidade usa outras régua: % da **FC máxima** ou de reserva, METs, ou a PSE. Em todas as modalidades, o princípio é o mesmo: a intensidade precisa ser **prescrita e monitorada**, não deixada ao acaso — é ela que define se o estímulo cai na zona que produz a adaptação desejada.

QUAL RÉGUA USAR

Para iniciantes, a **faixa de repetições** + RIR é mais segura e prática que testar 1RM. Para avançados e força máxima, o **% de 1RM** dá precisão. O profissional competente transita entre as escalas conforme o aluno e o objetivo — e ensina o aluno a perceber o próprio esforço (RIR).

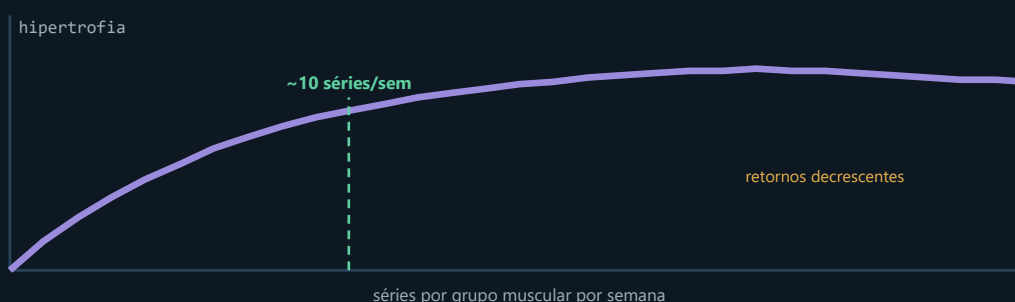
1.3

Volume: a Dose que Constrói

Se a intensidade define a qualidade do estímulo, o volume define a quantidade. E há uma dose-resposta clara — até certo ponto.

O volume é a quantidade total de trabalho — no resistido, geralmente contado em **séries por grupo muscular por semana**. É um dos principais motores da hipertrofia, e a literatura mostra uma relação dose-resposta: mais volume, mais ganho — porém com **retornos decrescentes** e um teto a partir do qual o excesso atrapalha.

FIG. 1.3 – DOSE-RESPOSTA DO VOLUME (HIPERTROFIA)



A hipertrofia cresce com o volume semanal, mas com retornos decrescentes. ~10+ séries por grupo/semana superam claramente <5; volumes muito altos rendem cada vez menos e podem prejudicar (Schoenfeld et al., 2017).

As implicações práticas são diretas: para hipertrofia, mirar **pelo menos ~10 séries semanais por grupo** é um bom ponto de partida; iniciantes respondem com menos. Para força, o volume é menor e a intensidade manda; para resistência muscular, o volume é maior com cargas leves. O volume também precisa ser **recuperável** — volume que excede a capacidade de recuperação vira fadiga, não ganho.

EVIDÊNCIA

Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. "Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis." *Journal of Sports Sciences*, 2017 [A2]: 10+ séries/grupo/semana > <5 séries; ganho graduado por série, com retornos decrescentes.

COMECE BAIXO, PROGRIDA O VOLUME

Erro comum é começar com volume altíssimo "para acelerar". Melhor iniciar no mínimo eficaz e **aumentar o volume ao longo das semanas** — isso deixa margem para progredir e reduz risco de lesão e overreaching. Volume é uma alavanca de progressão, não um ponto de partida máximo.

1.4

Tipo e Especificidade

Qual exercício escolher é uma decisão guiada pelo objetivo. A especificidade é a bússola — mas tem limites que o profissional precisa conhecer.

O "Tipo" do FITT-VP é a modalidade e os exercícios escolhidos. A regra-mestra é a **especificidade**: a adaptação é específica ao estímulo, então o treino deve se parecer com o objetivo. Quem quer força máxima treina cargas altas; quem quer resistência aeróbia treina volume aeróbio; quem quer um gesto esportivo treina padrões parecidos com ele.

Mas a especificidade tem **nuances** que separam o profissional do amador:

- **Especificidade não é literalidade.** Treinar "específico" não significa só imitar o gesto com peso — isso pode prejudicar a técnica. Desenvolve-se a capacidade física (força, potência) e treina-se o gesto separadamente.
- **Base geral sustenta o específico.** Antes de especializar, constrói-se uma base ampla (força, mobilidade, condicionamento). Pular a base limita o teto do específico.
- **Transferência tem limites.** Nem todo exercício "funcional" transfere para o objetivo. A transferência é maior quanto mais o treino compartilha demandas com a meta.

OBJETIVO	TIPO DE ESTÍMULO PRIORITÁRIO
Força máxima	Cargas altas, exercícios multiarticulares, baixas repetições.
Hipertrofia	Volume moderado-alto, variedade de exercícios e ângulos.
Resistência aeróbia	Exercício rítmico contínuo/intervalado de grandes grupos.
Saúde geral	Combinação de resistido + aeróbio + mobilidade (recomendação ACSM).

A REGRA PRÁTICA DA ESPECIFICIDADE

Pergunte sempre: "este exercício compartilha demandas com o objetivo do aluno?" Quanto mais sim, maior a transferência. Mas reserve espaço para a **base geral** — ela é o que dá teto ao trabalho específico mais adiante.

// PARTE II

Prescrição Resistida

Agora o detalhe do treino com pesos: como ajustar as variáveis por objetivo, escolher os exercícios certos, ordená-los para extrair o máximo e dosar o descanso. É o coração da prescrição na academia.

2.0 Variáveis por Objetivo

a tabela que resolve a maioria dos casos

2.1 Seleção de Exercícios

multi vs. uni, livre vs. máquina

2.2 Ordem dos Exercícios

a sequência importa mais do que parece

2.3 Intervalo & Tempo sob Tensão

o que acontece entre as séries

2.0

Variáveis por Objetivo

A tabela que todo profissional deveria ter na cabeça: como carga, repetições, séries e descanso mudam conforme a meta.

A combinação de intensidade, repetições, séries e descanso muda o "endereço" do estímulo. Esta é a referência prática (alinhada a ACSM/NSCA) para os quatro objetivos resistidos clássicos:

OBJETIVO	INTENSIDADE	REPS	DESCANSO	FOCO
Força máxima	≥85% 1RM	≤6	2–5 min	Carga alta, baixo volume
Hipertrofia	67–85% 1RM	6–12	60–90 s	Volume + proximidade da falha
Resist. muscular	≤67% 1RM	≥12–15	≤30 s	Cargas leves, muitas reps
Potência	30–60% (ou técnica)	1–5 explosivas	2–5 min	Velocidade máxima, baixa fadiga

Algumas leituras importantes dessa tabela: as faixas **se sobrepõem** (hipertrofia e força compartilham território), o que permite treinar mais de um objetivo ao mesmo tempo. E a proximidade da **falha** (RIR baixo) é o que faz cargas moderadas ainda gerarem hipertrofia — não é só o peso, é o esforço efetivo.

COMO USAR NA PRÁTICA

Defina o objetivo dominante do mesociclo e use a linha correspondente como ponto de partida — depois ajuste ao aluno. Para a maioria das pessoas que treinam por estética e saúde, a faixa de **hipertrofia** (6–12 reps, RIR 1–3) é o "cavalo de batalha", com toques de força e resistência conforme a necessidade.

2.1

Seleção de Exercícios

Multiarticular ou isolado? Peso livre ou máquina? As escolhas não são "certo vs. errado" — são ferramentas para objetivos diferentes.

Escolher exercícios é equilibrar eficiência, especificidade e segurança. Duas decisões aparecem o tempo todo:

MULTIARTICULAR × UNIARTICULAR

Multiarticulares (agachamento, supino, terra) movem várias articulações, recrutam mais massa muscular e dão mais "retorno por exercício" — devem ser a base. **Uniarticulares** (rosca, extensão) isolam um músculo, úteis para focar pontos fracos e dar volume com menos fadiga sistêmica.

PESO LIVRE × MÁQUINA

Pesos livres exigem mais estabilização e transferem melhor a tarefas reais. **Máquinas** fixam a trajetória (mais seguras para iniciante/isolar, ótimas para falhar com segurança). Não há vencedor universal — há a ferramenta certa para o aluno e o momento.

Um guia mental útil é pensar em **padrões de movimento**, garantindo que o programa cubra todos: agachar, dobrar o quadril (hinge), empurrar (horizontal e vertical), puxar (horizontal e vertical), carregar/transportar e rotacionar. Montar o treino por padrões — em vez de "por músculo" — produz programas mais equilibrados e funcionais.

PADRÃO DE MOVIMENTO	EXEMPLOS
Agachar	Agachamento, leg press, afundo.
Dobrar quadril (hinge)	Levantamento terra, stiff, elevação pélvica.
Empurrar	Supino, desenvolvimento, flexão.
Puxar	Remada, puxada, barra fixa.

A REGRA DOS PADRÕES

Um programa equilibrado cobre todos os padrões fundamentais. Se o treino tem muito "empurrar" e pouco "puxar", há desequilíbrio à vista. Montar por padrões é o atalho para não deixar lacunas — e para equilibrar a musculatura.

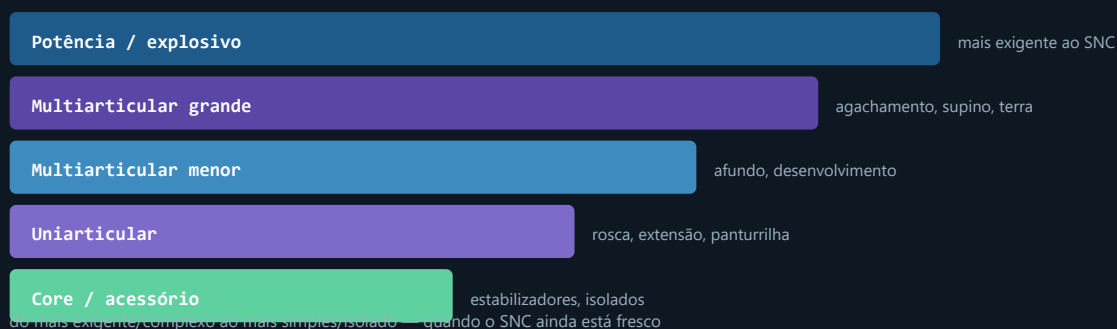
2.2

Ordem dos Exercícios

A sequência dos exercícios na sessão muda o desempenho e o estímulo. Há uma lógica clara — e exceções deliberadas.

A ordem importa porque a fadiga se acumula ao longo da sessão: o que vem primeiro é feito com mais energia e qualidade. A recomendação do ACSM segue uma hierarquia que prioriza o que mais exige do sistema nervoso e da técnica:

FIG. 2.2 – A HIERARQUIA DE ORDEM DOS EXERCÍCIOS



Do mais exigente ao mais simples: potência/explosivo → multiarticulares grandes → multiarticulares menores → uniaxiais → core/acessórios. A regra protege a qualidade dos movimentos que mais dependem de frescor.

- **Potência e explosivos primeiro:** exigem máximo frescor do sistema nervoso (saltos, levantamentos olímpicos).
- **Multiarticulares antes de uniaxiais:** os grandes movimentos rendem mais quando você está descansado.
- **Grandes grupos antes de pequenos:** não fadigue os estabilizadores pequenos antes dos grandes exercícios.
- **Prioridade ao objetivo:** o ponto fraco ou a prioridade do mesociclo pode ser antecipado, mesmo "fora da regra".

A EXCEÇÃO DELIBERADA (PRÉ-EXAUSTÃO E PRIORIDADE)

Às vezes invertemos a ordem de propósito: colocar um exercício de prioridade **primeiro** (mesmo que pequeno) garante que ele receba energia máxima. É a regra do "primeiro o que mais importa para o objetivo" — a hierarquia geral é o padrão, mas a prioridade do aluno pode reorganizá-la.

REFERÊNCIA

ACSM Position Stand. "Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults." *Med Sci Sports Exerc*, 2009 [A1]: recomendações de ordem por nível e objetivo.

2.3

Intervalo e Tempo sob Tensão

O que acontece entre as séries e a velocidade de cada repetição também são variáveis prescritíveis — e frequentemente esquecidas.

Duas variáveis "invisíveis" moldam o estímulo tanto quanto carga e reps: o **intervalo de descanso** entre séries e a **cadência** (tempo sob tensão) de cada repetição.

INTERVALO DE DESCANSO

- **Força / potência (2–5 min):** descanso longo recupera o sistema nervoso e os fosfatos, permitindo manter cargas altas e qualidade.
- **Hipertrofia (60–90 s+):** a evidência atual mostra que descansos **mais longos** (não tão curtos quanto se pregava) sustentam volume e, com ele, a hipertrofia. Descanso curtíssimo derruba o volume.
- **Resistência muscular (≤ 30 s):** descanso curto mantém a demanda metabólica alta, treinando a tolerância à fadiga.

CADÊNCIA / TEMPO SOB TENSÃO

A velocidade de execução (ex.: 3 s na descida, 1 s na subida) altera o tempo sob tensão e a ênfase. Descidas controladas aumentam o estímulo excêntrico; tentar mover rápido na fase concêntrica (com controle) favorece força e potência. O essencial é a **intenção** e o controle — não decorar números mágicos de cadência.

O MITO DO "DESCANSO CURTO QUEIMA MAIS GORDURA"

Reduzir o descanso a poucos segundos para "queimar mais" costuma **sabotar o estímulo de força/hipertrofia** ao derrubar a carga e o volume. Para gasto calórico, há ferramentas melhores (volume total, aeróbio). Deixe o descanso a serviço da qualidade do estímulo resistido.

REGRA SIMPLES DE DESCANSO

Quanto mais pesado e multiarticular o exercício, mais longo o descanso. Agachamento pesado pede 2–3 min; rosca de bíceps, ~60 s. Ajuste pela recuperação real: a próxima série deve poder ser feita com qualidade.

// PARTE III

A Sessão e a Semana

Variáveis isoladas viram resultado quando organizadas no tempo: a estrutura da sessão, a divisão da semana, o aeróbio e a mobilidade. Aqui a prescrição vira agenda concreta.

3.0 Anatomia da Sessão

aquecimento, principal, volta à calma

3.1 Divisões & Frequência

full-body, upper/lower, push-pull-legs

3.2 Prescrição Aeróbia

zonas, contínuo e intervalado

3.4 Concorrente & Emagrecimento

combinar sem sabotar

3.0

A Anatomia de uma Sessão

Toda sessão bem prescrita tem três partes com funções distintas. Pular uma delas custa qualidade — ou segurança.

Uma sessão de treino não é só "a lista de exercícios". Ela tem uma estrutura com começo, meio e fim, cada parte com um papel:

FIG. 3.0 – A ESTRUTURA DE UMA SESSÃO

a anatomia de uma sessão — proporções aproximadas do tempo



Aquecimento (prepara corpo e sistema nervoso), parte principal (o estímulo que gera adaptação) e volta à calma (transição para a recuperação). As proporções variam com o objetivo.

- **Aquecimento (8–12 min):** elevação geral (cardio leve) + mobilidade específica + séries de aproximação no primeiro exercício. Prepara articulações, eleva a temperatura e "liga" o sistema nervoso.
- **Parte principal:** onde mora o estímulo — os exercícios na ordem definida (2.2), com as variáveis do objetivo. É aqui que a adaptação é provocada.
- **Volta à calma (5–8 min):** redução gradual, mobilidade/alongamento leve. Inicia a transição para a recuperação e fecha a sessão.

O **aquecimento** é a parte mais negligenciada e a de melhor custo-benefício: prepara para render mais na parte principal e reduz risco. Não precisa ser longo — precisa ser **específico** ao que vem a seguir (aquecer os padrões e articulações que serão exigidos).

AQUECIMENTO ESPECÍFICO > GENÉRICO

Dez minutos de esteira não preparam o ombro para o supino. O melhor aquecimento combina elevação geral breve + mobilidade das articulações-alvo + **séries de aproximação** (rampas de carga) no primeiro exercício principal. Aquecer é ensaiar o movimento que vem.

3.1

Divisões de Treino e Frequência

Como distribuir os músculos pelos dias da semana. A melhor divisão é a que entrega o volume e a frequência certos — e que o aluno cumpre.

A "divisão" (split) organiza quais grupos são treinados em quais dias. A escolha depende da disponibilidade semanal e do volume desejado. As três mais usadas:

DIVISÃO	COMO FUNCIONA	FREQUÊNCIA IDEAL
Full-body	Corpo todo em cada sessão.	2–3×/semana
Upper / Lower	Alterna superiores e inferiores.	4×/semana
Push / Pull / Legs	Empurrar / puxar / pernas.	3 ou 6×/semana

O ponto-chave moderno é a **frequência por grupo muscular**: a evidência sugere que distribuir o volume semanal em **2 ou mais sessões por grupo** tende a ser tão bom ou melhor que concentrar tudo num "dia de" — sobretudo porque permite mais volume com qualidade. Isso favorece full-body, upper/lower e PPL de 6 dias sobre a clássica "divisão de um grupo por dia".

COMO ESCOLHER A DIVISÃO

Parta da disponibilidade: 2–3 dias → full-body; 4 dias → upper/lower; 5–6 dias → PPL ou híbridos. Garanta que cada grupo seja treinado **≥2×/semana** e que o volume semanal-alvo caiba com qualidade. A melhor divisão no papel é inútil se não couber na rotina do aluno.

FREQUÊNCIA SERVE AO VOLUME

Frequência não é mágica por si só — ela é o **veículo** para acomodar o volume semanal com qualidade. Treinar um grupo 2× permite dividir 12 séries em 2×6 (frescas) em vez de 1×12 (fatigadas). O alvo é o volume semanal bem executado; a frequência é como você o entrega.

3.2

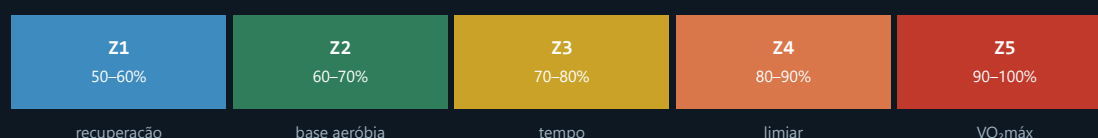
Prescrição Aeróbia

O FITT-VP também rege o cardio. Saber prescrever zonas e formatos é parte essencial — e frequentemente o elo fraco do profissional de musculação.

A prescrição aeróbia segue o mesmo FITT-VP, com a intensidade expressa em **zonas de frequência cardíaca** (ou PSE). A recomendação de saúde do ACSM (Garber, 2011) é referência: ao menos **150 min/semana** de intensidade moderada, ou **75 min/semana** de vigorosa (ou combinação).

FIG. 3.2 – ZONAS DE INTENSIDADE AERÓBIA

zonas de intensidade aeróbia (% da FC máxima)



Cinco zonas por % da FC máxima, da recuperação (Z1) ao VO₂máx (Z5). A maior parte do volume aeróbio de base deve ficar em Z2; o trabalho intenso (Z4–Z5) é menor em volume e mais potente em estímulo.

Dois grandes formatos cobrem a maioria dos objetivos: o **contínuo** (esforço estável, ótimo para base aeróbia e iniciantes) e o **intervalado** (alternância de esforço alto e recuperação, eficiente em tempo e potente para o VO₂). A escolha depende do objetivo, do tempo e do nível do aluno.

FORMATO	QUANDO USAR
Contínuo moderado	Base aeróbia, saúde, iniciantes, recuperação ativa.
Intervalado (HIIT)	Pouco tempo, melhorar VO ₂ máx, alunos já condicionados.
Misto / polarizado	Maior parte do volume leve (Z2) + doses de alta intensidade.

A BASE É LEVE, NÃO MODERADA-DIFÍCIL

Erro comum é fazer todo o cardio num "meio-termo" cansativo (Z3) que estressa sem o benefício do leve nem do intenso. Melhor **polarizar**: a maior parte em Z2 (conversável) + doses menores de alta intensidade. Mais resultado, menos fadiga acumulada.

3.3

Flexibilidade e Neuromotor

Os componentes que completam uma prescrição de saúde — e que o ACSM recomenda explicitamente, ao lado de força e cardio.

Uma prescrição completa de saúde, segundo o ACSM (Garber, 2011), não é só resistido + aeróbio: inclui também trabalho de **flexibilidade/mobilidade** e **neuromotor** (equilíbrio, coordenação, agilidade) — este último especialmente importante em idosos.

COMPONENTE	RECOMENDAÇÃO ACSM (GERAL)
Flexibilidade	≥2–3×/semana; alongar até leve desconforto, manter ~10–30 s; melhor com o corpo aquecido.
Neuromotor	≥2–3×/semana (sobretudo idosos): equilíbrio, agilidade, coordenação, propriocepção.

Na prática, esses componentes raramente precisam de uma sessão própria: encaixam-se no aquecimento (mobilidade dinâmica específica), entre séries (mobilidade de articulações travadas) ou na volta à calma (alongamento). O importante é que a prescrição os **contemple de propósito**, em vez de deixá-los ao acaso — especialmente a mobilidade das articulações-chave para os exercícios do aluno.

HONESTIDADE SOBRE ALONGAMENTO

Alongamento melhora amplitude, mas a evidência **não** sustenta que previna lesões ou que o alongamento estático intenso **antes** do treino de força melhore o desempenho (pode até reduzir força momentânea). Prescreva mobilidade para destravar movimento; deixe o alongamento estático mais longo para depois do treino.

NEUROMOTOR: O COMPONENTE ESQUECIDO

Equilíbrio e coordenação são treináveis e altamente relevantes para a **autonomia**, sobretudo a partir da meia-idade. Incluir trabalho neuromotor (apoios unipodais, mudanças de direção, padrões coordenados) é simples e diferencia uma prescrição de saúde de qualidade.

3.4

Treino Concorrente e Emagrecimento

Combinar força e aeróbio é o caso mais comum na prática — e tem regras para não um sabotar o outro.

A maioria dos alunos quer **as duas coisas**: ganhar/preservar músculo e melhorar o condicionamento (ou emagrecer). Treinar força e aeróbio juntos é o "treino concorrente" — e há um fenômeno a gerenciar: em excesso e mal organizado, o aeróbio pode **interferir** nos ganhos de força/hipertrofia (o "efeito de interferência").

- **Priorize pela ordem na sessão:** se força é a prioridade, treine força **antes** do aeróbio (ou em sessões separadas). O que vem primeiro recebe mais energia.
- **Separe quando possível:** aeróbio e força em momentos/dias diferentes reduzem a interferência.
- **Dose o aeróbio:** volumes muito altos de aeróbio intenso competem mais com a força. Para quem quer músculo, o aeróbio é complemento, não o centro.

Para **emagrecimento**, a lógica muda de chave: o resistido **preserva a massa magra** durante o déficit (essencial para não "derreter" músculo junto com gordura), e o gasto vem da combinação de treino + atividade diária (NEAT) + dieta. O erro clássico é focar só em "cardio para queimar" e abandonar a força — perdendo músculo e desacelerando o metabolismo.

A PRESCRIÇÃO INTELIGENTE PARA EMAGRECER

Mantenha o **resistido como base** (preserva massa magra e o gasto de repouso), some aeróbio conforme a tolerância e o tempo, e priorize o déficit calórico via nutrição. Treinar para emagrecer é, antes de tudo, treinar para **não perder músculo** enquanto se perde gordura.

// PARTE IV

Progressão & Individualização

Um programa não é estático: ele evolui com o aluno. Esta parte trata de como progredir de forma sistemática, ajustar ao dia a dia e adaptar a prescrição a diferentes pessoas — com segurança.

4.0 Como Progredir

as alavancas da sobrecarga progressiva

4.1 Autorregulação

o plano que se ajusta ao dia

4.2 Populações & Segurança

adaptar sem perder o princípio

4.0

Como Progredir

Sobrecarga progressiva é o motor de todo ganho. Mas "progredir" é muito mais do que "colocar mais peso".

Sem progressão, a adaptação para. Mas a carga é apenas **uma** das formas de progredir — e nem sempre a melhor a cada semana. O profissional tem várias alavancas, e saber alterná-las mantém o aluno evoluindo mesmo quando o peso não pode subir:

ALAVANCA	COMO AUMENTA O ESTÍMULO
Carga	Mais peso na barra (a via clássica de força).
Repetições	Mais reps com a mesma carga (base da dupla progressão).
Séries (volume)	Mais séries no total semanal (motor de hipertrofia).
Densidade	Mesmo trabalho em menos tempo (descanso menor).
Proximidade da falha	Menos reps na reserva (RIR menor), com cautela.
Amplitude / cadência	ADM maior, excêntrica mais lenta, pausas.

FIG. 4.0 – A DUPLA PROGRESSÃO



Suba as repetições até o topo da faixa-alvo (ex.: de 8 a 12) com a mesma carga; ao bater o topo, aumente a carga e recomece no piso da faixa. Progressão sustentável para a maioria dos alunos.

A DUPLA PROGRESSÃO NA PRÁTICA

É o método mais robusto para a maioria: defina uma faixa (ex.: 8–12). Comece com carga que permita 8 com 1–2 RIR. Semana a semana, busque mais reps; ao fazer 12 com boa forma, **suba a carga** e volte para ~8. Simples, autorregulável e sem precisar testar 1RM toda hora.

4.1

Autorregulação: o Plano que se Ajusta

Nenhum aluno está 100% todos os dias. A autorregulação adapta a carga ao estado real — e é o que torna o programa resiliente à vida.

Um plano fixo no papel encontra um corpo que varia: noite mal dormida, semana estressante, um pico de energia. A autorregulação usa o feedback do próprio aluno para ajustar a carga do dia, mantendo o estímulo adequado em vez de cego. As duas ferramentas centrais:

- **RIR / RPE:** prescreve-se pelo esforço ("faça 8 com 2 reps na reserva") em vez de só pela carga absoluta. Em dia ruim, a carga que corresponde a 2 RIR será menor — e tudo bem.
- **Treino baseado em velocidade (VBT):** usa a velocidade da barra como termômetro — quando cai além de um limite, encerra-se a série. Objetivo e preciso, exige equipamento.

A autorregulação resolve um problema real: a carga "do plano" pode estar leve demais (desperdício) ou pesada demais (risco e má execução) num dia específico. Prescrever pelo **esforço-alvo**, e não só pelo número fixo, mantém o estímulo na faixa certa todos os dias — e ensina o aluno a se conhecer.

COMO INTRODUZIR RIR AO ALUNO

Comece simples: peça que, ao fim da série, estime "quantas reps ainda daria". No início ele subestima; com semanas, calibra. Use isso para ajustar carga: se o RIR está alto demais, suba o peso; se chega à falha sem querer, reduza. É o "controle de qualidade" do estímulo, sessão a sessão.

PLANO FIRME, EXECUÇÃO FLEXÍVEL

Autorregular não é improvisar. A estrutura (exercícios, faixas, progressão) permanece firme; o que se ajusta é a **carga do dia** dentro dela. É o equilíbrio entre ter um plano e respeitar o corpo — rigidez e improviso, ambos, prejudicam o resultado.

4.2

Populações e Segurança

Os princípios não mudam — muda a calibração. Adaptar a prescrição a diferentes pessoas, sem abandonar o que funciona.

A prescrição se ajusta ao aluno sem trair os princípios. O que muda entre populações é, sobretudo, o **ponto de partida**, a **velocidade de progressão** e a **margem de segurança**:

POPULAÇÃO	AJUSTES PRINCIPAIS
Iniciante	Foco em técnica, cargas conservadoras, full-body, progressão rápida (ganhos iniciais grandes), simplicidade.
Avançado	Mais volume e variação, progressão mais lenta, periodização mais fina, autorregulação.
Idoso	Ênfase em força e potência (sarcopenia) e neuromotor; aquecimento ampliado; progressão gradual.
Condições de saúde	Triagem e, quando indicado, liberação médica; adaptar carga e exercícios; trabalhar dentro do escopo profissional.

Em todos os casos, a **segurança** obedece à mesma lógica vista na biomecânica: casar a demanda do exercício com a capacidade atual do tecido e progredir essa capacidade ao longo do tempo. Iniciar conservador e progredir é quase sempre mais seguro e eficaz que "começar pesado para acelerar".

OS LIMITES DO ESCOPO

O profissional de Educação Física prescreve exercício para a saúde e a performance — não trata doenças. Diante de condições clínicas (cardíacas, metabólicas descompensadas, dor importante), o caminho é **integrar-se** à equipe de saúde e atuar dentro do seu escopo, com liberação quando indicada. Reconhecer o limite é competência, não fraqueza.

// PARTE V

Ferramentas de Trabalho

O fechamento prático: uma prescrição completa montada do zero num estudo de caso, um modelo de programa para preencher, o checklist do FITT-VP e o glossário técnico.

5.0 Estudo de Caso

uma prescrição do diagnóstico ao programa

5.1 Modelo & Checklist

prontos para usar

– Erros, Cartão & Glossário

a síntese de bolso

5.0

Estudo de Caso Aplicado

Homem, 30 anos, intermediário, objetivo de hipertrofia, 4 dias/semana. Uma prescrição completa, variável por variável.

Diagnóstico: 30 anos, ~2 anos de treino, sem restrições, quer ganhar massa, dispõe de 4 dias/semana de ~60 min. **Objetivo dominante:** hipertrofia. **Decisões via FITT-VP:**

VARIÁVEL	DECISÃO	JUSTIFICATIVA
Frequência	4×/sem (upper/lower)	Cada grupo 2×/sem (frequência × volume).
Intensidade	67–82% · 8–12 reps · RIR 1–2	Faixa de hipertrofia, perto da falha.
Volume	~12–16 séries/grupo/sem	Acima de 10, com margem p/ progredir.
Tipo / seleção	Multi na base + isolados	Cobre padrões; isolados p/ pontos fracos.
Ordem	Multi grande → menor → isolado	Qualidade nos grandes movimentos.
Descanso	90–120 s (multi) / 60 s (isolado)	Sustenta volume com qualidade.
Progressão	Dupla progressão (8→12)	Sobe reps, depois carga; descarga a cada 5–6 sem.

LEITURA DO CASO

Repare que **cada decisão é justificável** — não há "achismo". O FITT-VP foi percorrido inteiro, a tabela de objetivo guiou a intensidade/volume, a ordem seguiu a hierarquia, e a progressão foi definida de antemão. Esse é o método: do diagnóstico ao programa, sem buracos.

O MESMO ROTEIRO PARA QUALQUER ALUNO

Mude o objetivo para força e a tabela da §2.0 reescreve intensidade, reps e descanso; mude a disponibilidade e a divisão se ajusta. A **estrutura** (percorrer o FITT-VP) é sempre a mesma — muda o conteúdo de cada variável.

5.1

Modelo & Checklist

Copie ou imprima. O modelo de prescrição preenchível e o checklist do FITT-VP para não esquecer nenhuma variável.

CABEÇALHO				
Aluno / objetivo				
Disponibilidade / divisão				

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS / RIR	DESCANSO	PROGRESSÃO

CHECKLIST FITT-VP (ANTES DE ENTREGAR O PROGRAMA)

Frequência	() cada grupo $\geq 2 \times$ /sem · () cabe na rotina
Intensidade	() faixa/RIR definidos por objetivo
Tempo	() sessão realista (aquece + principal + calma)
Tipo	() cobre os padrões · () específico ao objetivo
Volume	() séries/grupo/sem adequadas e recuperáveis
Progressão	() regra de progressão definida · () descarga prevista

Quer os modelos editáveis + minha mentoria para montar e revisar prescrições? Eu te ajudo a aplicar o FITT-VP nos seus alunos.

Quero a mentoria

// SÍNTESE

Erros Comuns e Cartão Técnico

Os deslizes que mais comprometem uma prescrição — e o resumo de tudo em poucas linhas.

- 1 **Prescrever sem objetivo claro.** Sem definir a meta dominante, as variáveis ficam sem âncora e o programa não tem direção.
- 2 **Esquecer a progressão.** Montar um bom treino e nunca avançá-lo — o aluno faz os mesmos pesos por meses e estagna.
- 3 **Volume alto demais cedo demais.** Começar no teto não deixa margem para progredir e aumenta risco de lesão e overreaching.
- 4 **Ignorar a recuperação.** Prescrever volume que excede a capacidade de recuperar — fadiga acumulada vira platô, não ganho.
- 5 **Copiar treinos prontos.** Aplicar o programa de outra pessoa, ignorando o objetivo, o nível e a rotina do aluno à frente.
- 6 **Descuidar do aeróbio e da mobilidade.** Tratar a prescrição como "só musculação" e deixar saúde cardiorrespiratória e mobilidade de fora.

CARTÃO TÉCNICO – O ESSENCIAL EM 5 LINHAS

1. Percorra o FITT-VP inteiro em toda prescrição. · 2. Intensidade e volume seguem a tabela do objetivo (§2.0). · 3. Ordene do mais exigente ao mais simples. · 4. Cada grupo $\geq 2\times/\text{sem}$; $\sim 10+$ séries/sem p/ hipertrofia. · 5. Defina a progressão de antemão (dupla progressão) e autorregule pelo RIR.

*"Cada variável do treino
deve ser uma **escolha**, não um acaso."*

Glossário Técnico

Os termos centrais da prescrição de exercício, em uma página, para consulta e para explicar ao aluno.

TERMO	DEFINIÇÃO
FITT-VP	Frequência, Intensidade, Tempo, Tipo, Volume e Progressão (ACSM).
Frequência	Número de sessões (ou de estímulos por grupo) por semana.
Intensidade	Magnitude do esforço (% 1RM, RIR, % FC, PSE).
Volume	Trabalho total; no resistido, séries/grupo/semana.
1RM	Carga máxima para uma repetição; referência de intensidade.
RIR	Repetições em reserva; quão longe da falha terminou a série.
RPE	Percepção subjetiva de esforço (escala de intensidade).
Falha (concêntrica)	Incapacidade de completar mais uma repetição com boa forma.
Sobrecarga progressiva	Aumento gradual da exigência ao longo do tempo.
Dupla progressão	Subir reps até o topo da faixa, depois aumentar a carga.
Multiarticular	Exercício que move várias articulações (ex.: agachamento).
Uniaarticular	Exercício de uma articulação (ex.: rosca, extensão).
Padrão de movimento	Categoria de movimento (agachar, hinger, empurrar, puxar...).
Split (divisão)	Forma de distribuir os grupos musculares pelos dias.
Tempo sob tensão	Duração da tensão na série (ligado à cadência).
Treino concorrente	Treinar força e aeróbio no mesmo período.
Efeito de interferência	Aeróbio em excesso pode atenuar ganhos de força/hipertrofia.
HIIT	Treino intervalado de alta intensidade.
Autorregulação	Ajustar a carga do dia ao estado real do aluno (RIR/VBT).
FC de reserva	Diferença entre FC máxima e de repouso; base de zonas.
MET	Equivalente metabólico; unidade de gasto energético do exercício.
NEAT	Gasto de atividade não-exercício (movimento do dia a dia).
Densidade	Relação trabalho/descanso; mesmo trabalho em menos tempo.
Séries de aproximação	Séries leves de "rampa" que preparam para a carga de trabalho.
VBT	Treino baseado na velocidade da barra; autorregula a carga.

// CONTINUE EVOLUINDO COMO PROFISSIONAL

Prescreva com Método e Confiança

Você tem o arcabouço completo do FITT-VP à disposição. O próximo passo é aplicá-lo com fluência e ter os modelos prontos para o dia a dia.

Montar prescrições sólidas, rápidas e justificáveis é uma habilidade que se afia com prática e feedback. Na **Mentoria PER4MANCE para Profissionais**, eu reviso suas prescrições, te entrego modelos editáveis e te ajudo a aplicar o FITT-VP em casos reais.

Mentoria PER4MANCE · Profissionais

PRESCRIÇÃO APLICADA · MODELOS · PROGRESSÃO

- ✓ **Modelos de prescrição** editáveis, por objetivo.
- ✓ **Revisão dos seus programas** sob a ótica do FITT-VP.
- ✓ **Biblioteca de progressões** e divisões prontas.
- ✓ **Suporte direto** para tirar dúvidas comigo no WhatsApp.

Quero a mentoria · Falar no WhatsApp

1**CONVERSA**

Você me chama e conta o seu momento profissional.

2**FERRAMENTAS**

Recebe modelos e revisões das suas prescrições.

3**FLUÊNCIA**

Você prescreve com método e segurança.

Transforme Objetivo em Programa.

Você tem agora o método completo: do FITT-VP às variáveis por objetivo, da montagem da sessão à progressão e à autorregulação. Falta torná-lo automático no seu dia a dia — e é nisso que eu te acompanho.

Mentoria PER4MANCE · Profissionais

Modelos, revisão de prescrição e casos reais — o método deste manual aplicado à sua rotina profissional.

Agendar conversa no WhatsApp · (31) 9 9329-0622

WHATSAPP

(31) 9 9329-0622

INSTAGRAM

@preparadorfisico_gustavo

SITE

seuproximonivelestaqui.com.br

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS · QUALIS A1-A2

[A1] Garber CE et al. (ACSM Position Stand). "Quantity and Quality of Exercise..." *Med Sci Sports Exerc*, 43(7):1334–59, 2011. · **[A1]** ACSM Position Stand. "Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults." *Med Sci Sports Exerc*, 41(3):687–708, 2009. · **[A2]** Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. "Dose-response relationship between weekly resistance training volume and muscle mass." *J Sports Sci*, 2017. · ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10ª ed.); NSCA Essentials. · Material técnico-educativo; não substitui avaliação individual.